



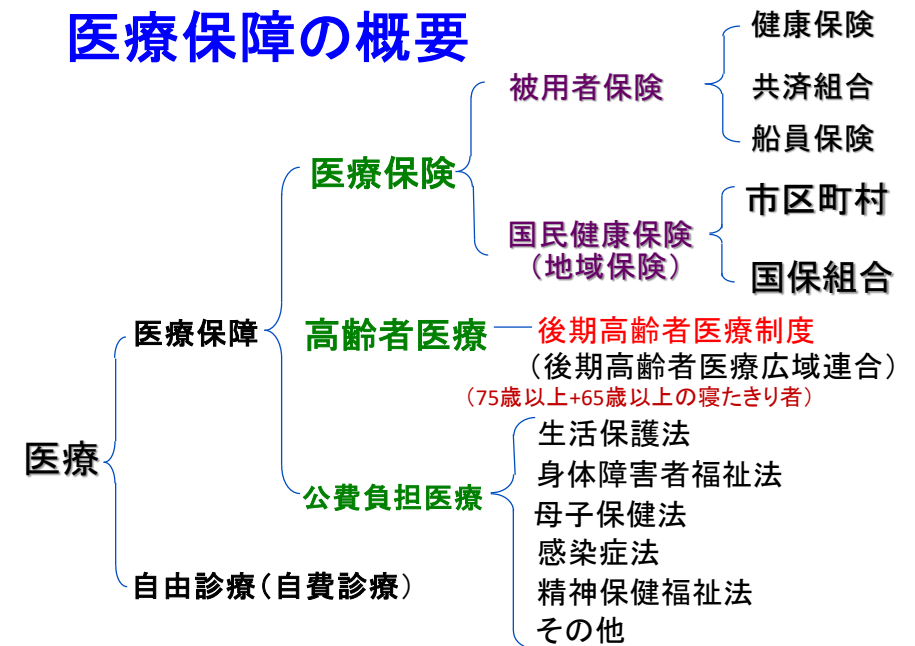
保健医療論 (2)

社会保障制度2

環境労働衛生学 上島通浩

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

医療保障の概要



医療保険に関係する主な法律

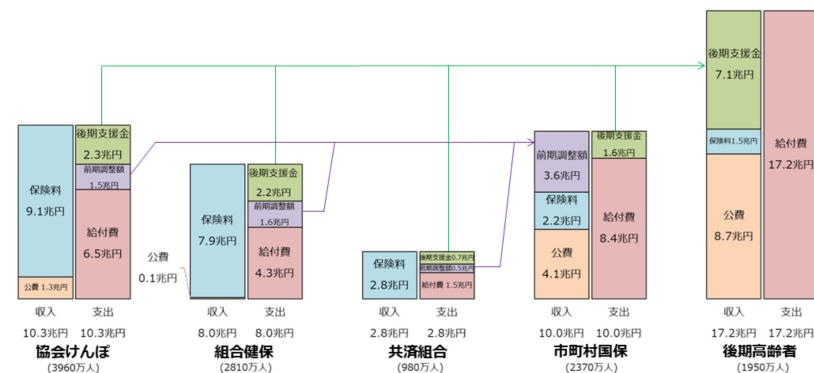
- 健康保険法
 - 被用者保険、主に会社員等の医療保険の基本法
- 国民健康保険法
 - 自営業者、無職者、退職者などを含む国民健康保険の基本法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
 - 後期高齢者医療制度、特定健診・特定保健指導等

我が国の医療保険制度

わが国の医療保険制度の特徴

- ・ 国民皆保険
 - － 全ての国民が何らかの公的医療保険で保障される(1961年～)
- ・ 現物給付
 - － 患者は窓口で一部負担金を払い、医療サービスそのものを受ける
- ・ 社会保険方式
 - － 保険料を主な財源としつつ公費も投入される
- ・ フリーアクセス
 - － 患者が医療機関を選択して受診できる

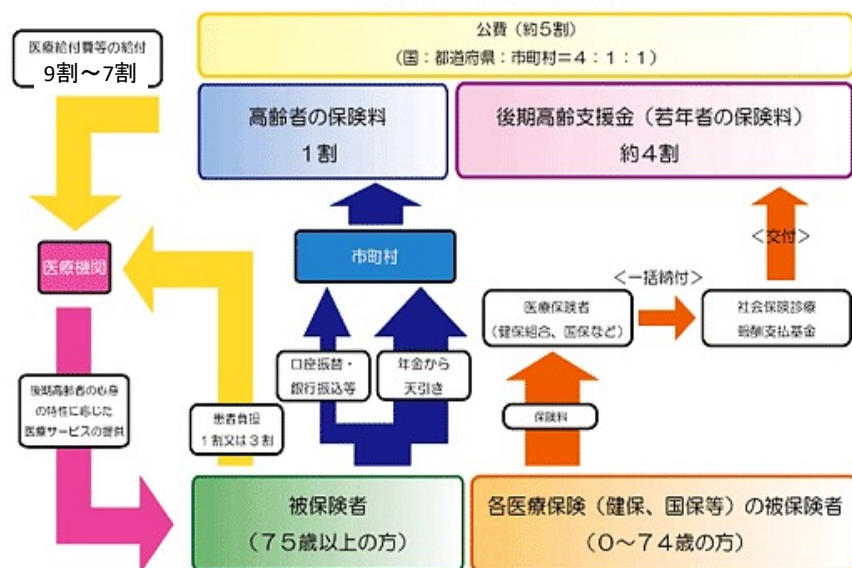
医療保険の制度別の財政 (2023年度)



出典: 厚生省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuhoken/newpage_21420.html

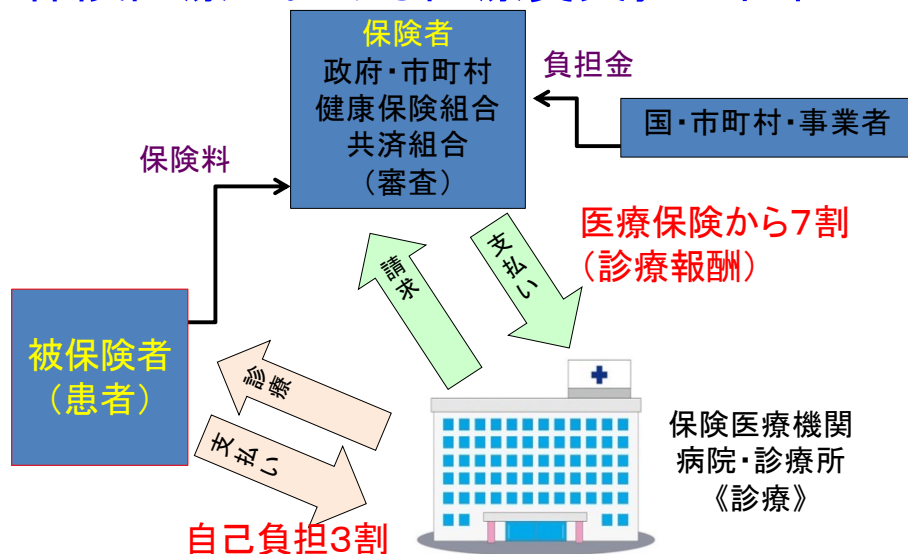
後期高齢者医療制度の運営の仕組み



医療保険における自己負担増加

- ・ 疾患の種類や性質によって是非は異なる
- ・ 低所得層への配慮が必要
- ・ 予防的ケアに対する負の影響
- ・ 長期的な健康への影響は不明

保険医療における医療費支払の仕組み



診療報酬とは

医療機関が保険診療として受け取る公定価格

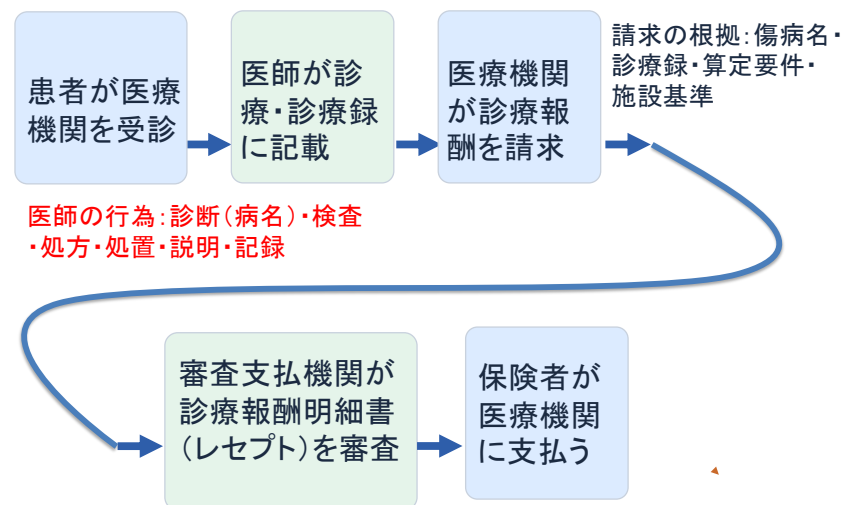
1点 = 10円

点数表に基づく「価格」と「要件」

基本診療料 初診・再診・入院料など	特掲診療料 検査・投薬・手術など	施設基準 人員・体制・届出など
----------------------	---------------------	--------------------

- ・「実施した」だけで算定できるとは限らない
- ・対象患者・回数制限・記録要件・説明要件がある
- ・医師は点数表の専門家でなくても、算定根拠を意識する必要がある

保険診療の診療報酬が支払われるまで



医師はレセプトを作らないが請求根拠を作る

医師の仕事

請求・審査で問われること

傷病名をつける	→	医学的必要性はあるか
検査をオーダーする	→	病名と診療内容が対応するか
処方する	→	算定要件を満たすか
指導・説明する	→	記録で確認できるか
診療録に記載する	→	患者負担は妥当か

診療録にない医学的判断は、第三者からは見えない。請求のために診療するのではない。必要な医療を行い、その必要性を説明できる形で残す。

診療と保険制度との関係

- 医師の診療行為は、患者の健康回復だけでなく、患者負担、医療機関の収入、保険財政への負担、公平な医療資源配分につながる
- 制度上の適正性、医学的必要性、患者への説明が求められる
- 判断と実施した内容が適切に診療録に記載されることの上に制度が成り立っている

医療費の一部が公費により 負担される医療（自己負担を軽減）

- ◆ 身体障害児：育成医療（児童福祉法）
- ◆ 小児慢性疾患：小児慢性特定疾患治療研究事業の対象 10疾患（児童福祉法）
- ◆ 未熟児：養育医療（母子保健法）
- ◆ 身体障害者：更生医療（身体障害者福祉法）
- ◆ 生活困窮者：医療扶助（生活保護法）

公費負担医療

医療費の一部が公費により 負担される医療（自己負担を軽減）

- ◆ 高齢者：高齢者医療（後期高齢者医療法）
- ◆ 結核：命令入所（感染症法）
- ◆ 1類・2類感染症：応急・措置入院（感染症法）
- ◆ 予防接種被害救済：予防接種法
- ◆ 措置入院：精神障害者保健福祉法
- ◆ 措置入院：麻薬中毒者（麻薬及び向精神薬取締法）
- ◆ 難病：特定疾患治療研究事業の対象疾患（56疾患）